













































No.	Nama	Penj.	Dispose / DPJP	RM
1	Ny. SITI NURUL LAILI	BPJS	EM -> Bedah TKV	11495448
2	Tn. BEJO	UMUM	EM -> MATA	14032700
3	Tn. DINAN	BPJS	EM -> NEURO	14032706
4	Ny. EUIS MARIAH	BPJS	EM	14032711
TPP IGD	No.	Modul / Tab	Deskripsi	
		1. Pendaftaran - SEP	SEP gagal di buat di modul pendaftaran, harus melalui modul bridging SEP.	
		2. SEP	SEP berhasil di buat apabila BPJS Non PBI, tetapi waktu di cetak hasil print Non PBI menjadi PBI.	
		3. Print Berkas	Print berkas rawat inap ,casemix, gelang pasien, dan lainnya belum mampu tercetak di loket TPP	
TRIAGE IGD	No.	Modul / Tab	Deskripsi	
		1. Assesment Triage	-	Assesment Triage terjadi error code saat di simpan.
			-	Saat peng-konesian pasien dengan TPP terjadi miss, assesment belum di isi tetapi sudah di koneksi oleh triage, sehingga isian triage hilang.
			-	apabila ada pasien setelah diperiksa triage tetapi tidak dimasukan ke emergency care (aps / pasien skrining) diberi tombol tersendiri untuk perubahan status tersebut.
			-	History triage diberi status.
			-	Proses transfer dari triage -> emergency care double, dikarenakan di transfer 2x, sehingga data di emergency care menjadi double, seharusnya ketika sudah di transfer tombol transfer harus non aktif / hidden.
EMERGENCY CARE	No.	Modul / Tab	Deskripsi	
		1. Daftar Pasien Rawat Darurat	-	Beberapa user DPJP ada yang belum bisa menampilkan daftar pasien rawat darurat, ada yang muncul semua (SMF).
			-	Tidak dapat menerima dispose dikarenakan EM salah menunjuk DPJP, seharusnya data pasien di koneksikan dengan SMF bukan DPJP, dikarenakan apabila terjadi kesalahan pemilihan DPJP data tersebut tidak dapat di proses oleh dokter yang di dispose.
			-	Notifikasi Konsul Tidak ada
			-	ICD 9 tidak sama dengan di sim-GOS.
			-	pencarian diagnosis pada permintaan darah tidak bisa tidak bisa keluar SPRI
			-	Pasien didisposed ke dr Singgih, saat log in dengan akun dr Atma nama pasien muncul, dengan dpjp lain yaitu dr syifa nama pasien tidak muncul.
			-	dokter menu reseptur di rawat inap untuk login dokter ahmad thohir tidak ada dokter
		3 Order Penunjang	-	Tindakan Lab beberapa tidak keluar.
			-	Lab Mikro masih belum.
		4 Daftar Rencana Operasi	-	Tabulasi Rujuk Bedah Sentral di ubah menjadi Kamar Operasi.
			-	Pengisian Asisten operator sampai dengan inputan isian ke bawah tidak perlu (hidden).
		5 Tarif Tindakan	-	Tarif tindakan konsultasi pada sim GOS Rp. 23.000,- di Inova konsul otomatis menjadi Rp. 10.000,-
			-	Cetakan tarif tindakan dirinciannya muncul tulisan SYSADMIN.
			-	Pencarian pasien order batal tidak bisa, sehingga PJA tidak dapat membatalkan tindakan.
LAB CENTRAL	No.	Modul / Tab	Deskripsi	
		1. Permintaan Order LAB	Hasil cetak billing huruf tidak jelas dan setting printer masih belum sesuai dengan ukuran kertas.	
		2. LAB Mikro	Miikro sdh Terima order, tapi billingnya hanya nyantol di pemeriksaan (pewarnaan Zn) padahal ada permintaan kultur jenis pemeriksaan juga, apakah utk kultur bs kami tambahkan d tabel periksaan tambahan atau bagaimana?	
		3 LAB PK	Sudah dicoba diperbaiki untuk cetak nota pemeriksaan sudah bisa kertas tdk menggulung ttp huruf masih ada yg belum jelas terbaca.	
LAB FARMASI	No.	Modul / Tab	Deskripsi	
		1.	double validasi pada menu pelayanan obat rumah sakit. validasi pertama untuk memasukkan obat dan "mencantolkan bahwa ada pelayanan farmasi" dan yg ke 2 untuk memvalidasi sesuai yg dilayani. karena dalam 1 permintaan obat dimungkinkan ada obat lain yg terdapat di depo lain atau gudang. bila tidak langsung di valid tidak bisa tersimpan obat ketinggalan. kalau di valid apa adanya tidak bisa karena 1. stok 0, 2. ketika obatnya datang ada kemungkinan sdh di close billing nb menu ini ada di standing order namun tidak ada di menu pelayanan obat rs baik ranap dan rajal.	
			menu cetak etiket baiknya bisa di cetak sebelum di valid. baik rajal ranap maupun standing order. melihat apabila obat high risk harus ada nama px nama obat dengan jelas ketika standing order.	
			menu retur tidak ada	
			nomer batch blm ada kolom	

				untuk cetak etiket ulang dan crtak nota ulang ketika halaman sdh di tutup blm bisa.
				hasil print nota penjualan tulisanya terlalu kecil
KEUANGAN	No.	Modul / Tab	Deskripsi	
	1.	Bank Jatim	Nilai uang pada kwitansi Bank Jatim ada selisih angka dengan nilai di keuangan	



1. MASUK PADA MENU **INFORMASI (PASIE RENCANA OPERASI)**
 - SUDAH MUNCUL PASIEN RUJUKAN OPERASI DARI POLI DAN RUANGAN SESUAI DENGAN YANG DISUMULASIKAN
 - PJ PENDAFTARAN IBS MASIH HARUS MELAKUKAN PENGISIAN INFORM CONTENT TINDAKAN DAN ANASTHESI SEBELUM BISA MASUK KE MENU **PERIKSA** UNTUK MELAKUKAN PENGATURAN PENDAFTARAN KAMAR OPERASI (SEHARUSNYA DIISI PERUJUK POLI /RUANGAN)
2. PROSES PENGATURAN PENDAFTARAN OK OLEH PJ PENDAFTARAN IBS PADA MENU **PERIKSA**
 - PILIHAN JUMLAH KAMAR OK MASIH BELUM LENGKAP DAN TIDAK BISA DIKETIK MANUAL
 - PILIHAN NAMA OPERATOR MASIH BELUM LENGKAP SEMUA SMF DAN TIDAK DAPAT DIKETIK MANUAL
 - PILIHAN NAMA ASISTEN OPERATOR LEBIH BAIK DIHILANGKAN JIKA HARUS ADA SEHARUSNYA TERISI NAMA PPDS
 - PILIHAN DOKTER RESUSITASI LEBIH BAIK DIHILANGKAN
 - PILIHAN NAMA DOKTER ANASTHESI BELUM LENGKAP TERISI PILIHAN DPJP OPERATOR
 - PILIHAN NAMA PENATA ANASTHESI TERISI PERAWAT IBS TIDAK BISA DIKETIK MANUAL
 - PILIHAN NAMA PERAWAT RR TERISI PERAWAT IBS TIDAK BISA DIKETIK MANUAL
 - PILIHAN NAMA PPDS LEBIH BAIK KETIKAN MANUAL KARENA SERING MENGALAMI PERUBAHAN
 - PILIHAN STATUS OPERASI TIDAK BISA TERISI
 - PILIHAN PEGAWAI MENGETAHUI SEBAIKNYA TERBATAS CUKUP KPP DAN KARU
 - PADA ITEM DATA KUNJUNGAN BEDAG SENTRAL (PILIHAN SMF TIDAK LENGKAP)
 - SITE MARKING HANYA MUNCUL PADA PASIEN YANG BERASAL DARI RAWAT INAP SAJA
3. PADA SAAT KITA MASUK KE MENU JADWAL OPERASI KELUAR VIEW TULISAN BAHASA PROGRAM
4. MASUK KE MENU **INFORMASI (DAFTAR PASIEN)**
 - ASSESMENT KEPERAWATAN SUDAH BISA TERISI
 - BELUM BISA MELAKUKAN PENGISIAN LEMBAR SSC KARENA ADA PERINTAH APPROVE YANG TIDAK DAPAT DILAKUKAN
 - LAPORAN OPERASI TIDAK DAPAT DIISI KARENA BELUM ADA PILIHAN DPJP MESKIPUN SUDAH MEMAKAI AKUN DARI DPJP PRIBADI
5. PADA MENU TRANSAKSI (PEMESANAN OBAT ALKES)
 - PEMESANAN DARI IBS KE FARMASI DILAKUKAN PERHARI BUKAN PERPASIEN SEHINGGA PEMESAN (IBS) MENGALAMI KESULITAN DALAM MENGIDENTIFIKASI KEBUTUHAN ALKES DAN BHP
 - DIUSULKAN PROSES PEMESANAN ALKES DAN BHP PER PASIEN DAN DALAM BENTUK PAKET YANG SELAMA INI SUDAH BERJALAN